

Alopécies

Introduction

= raréfaction ou disparition des cheveux

Interrogatoire: congénitale ou acquise, rapidité d'évolution, contexte particulier, contagé/entourage, prise médicamenteuse

Examen clinique +++: diffuse ou en plaque, inflammatoire / cicatricielle / cuir chevelu sains

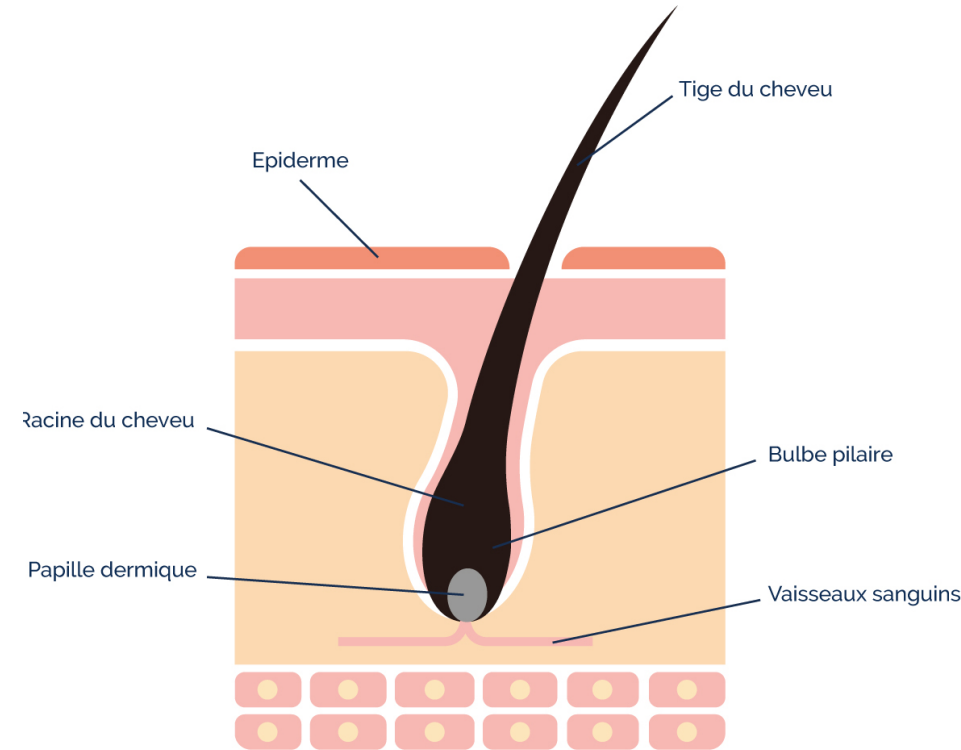
Examens complémentaires souvent non nécessaires

Challenge thérapeutique +++

Le cycle pilaire

Cheveu fait de 3 parties:

- **Le bulbe**
- **La tige pilaire**
- **La gaine**



Structure dynamique sous la dépendance de la **papille dermique** au contact du bulbe. Elle est richement vascularisée et apporte au bulbe les nutriments nécessaires à la production de la tige

Le cycle pilaire

100 000 à 150 000 cheveux

3 phases:

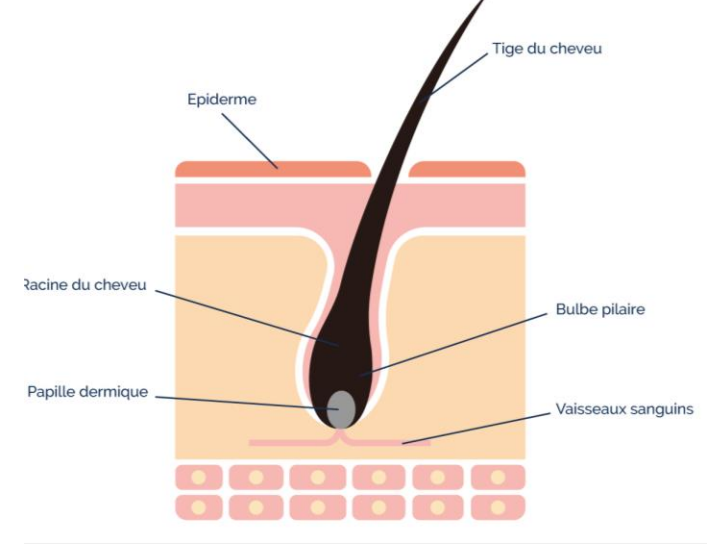
✓ **Phase anagène = croissance**

Détermine la longueur par production de la kératine à partir des cellules épithéliales bulbaires (0,3mm/j). Dure 3 à 6 ans.

✓ **Phase catagène = involution** (atrophie progressive du bulbe)

✓ **Phase télogène = repos puis chute**

Migration de la papille vers la surface puis chute du cheveu et naissance d'un nouveau bulbe à partir des cellules souches de la membrane basale épidermique. Dure 2 à 6 mois.



Le cycle pilaire

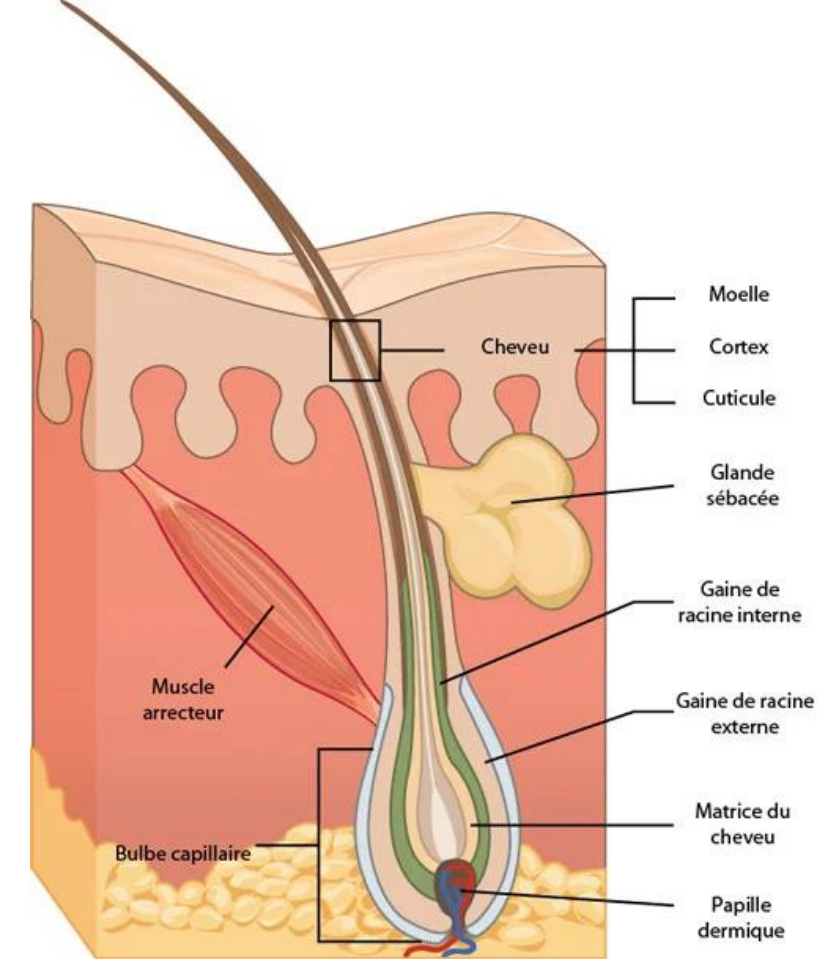
Un cheveu = **20 cycles**

Répartition:

85% anagène

5% catagène

10% télogène



Chute de cheveux quotidienne: de 50 à 150 cheveux !

Couleur dépendante du type de **mélanine** produite par les mélanocytes du bulbe

L'alopecie peut résulter de plusieurs mécanismes :

- ✓ **défaul de production du cheveu** : par carence (carence martiale), par troubles endocriniens (dysthyroïdie), par prise de toxique ou de certains médicaments (chimiothérapies) responsables d'un arrêt du cycle pileaire en phase anagène ou effluvium anagène,
- ✓ **miniaturisation du follicule pileux** puis disparition du follicule pileux à l'origine d'un éclaircissement de la chevelure puis d'une disparition des cheveux (golpes temporaux, vertex) au cours de l'alopecie androgénogénétique ou androgénique,
- ✓ **chute excessive** le plus souvent transitoire par une entrée prématurée en phase télogène (effluvium télogène),
- ✓ **anomalie de la structure de la tige pileaire** : génétique (dysplasie pileaire) ou acquise (dystrophie, trichotillomanie) ou destruction de la tige pileaire par des agents infectieux kératinophiles (teigne tondante)
- ✓ **réponse immune** dirigée contre le follicule pileux (pelade),
- ✓ **destruction du follicule pileux** d'origine physique, inflammatoire, infectieuse, tumorale à l'origine d'une alopecie dite cicatricielle.

Interrogatoire

L'interrogatoire recherchera plusieurs informations :

- ✓ **l'âge et les circonstances** de survenue : acquise ou congénitale
- ✓ **le mode d'apparition** : aigu ou chronique
- ✓ **les antécédents familiaux** d'alopécie androgénogénétique (qui peut s'ajouter à une autre cause d'alopécie)
- ✓ **les antécédents personnels** en particulier endocrinologiques (dysthyroïdie, irrégularités du cycle menstruel chez la femme) et d'éventuelles carences (régime alimentaire, pathologie associée, saignements)
- ✓ **les habitudes cosmétiques** (défrisage, traction, coloration)
- ✓ **les prises médicamenteuses**
- ✓ **les traitements reçus** pour l'alopécie

Examen physique

- ✓ **Aspect des cheveux:** surtout pour les alopécies congénitales (=dysplasie pilaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)





Examen physique

- ✓ Aspect des cheveux: surtout pour les alopecies congénitales (=dysplasie pilaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)
- ✓ **Densité**: pour authentifier l'alopecie



Examen physique

- ✓ Aspect des cheveux: surtout pour les alopecies congénitales (=dysplasie pileaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)
- ✓ Densité: pour authentifier l'alopecie
- ✓ **Test de traction:** positif si + de 2 cheveux sur 10



Examen physique

- ✓ Aspect des cheveux: surtout pour les alopécies congénitales (=dysplasie pilaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)
- ✓ Densité: pour authentifier l'alopecie
- ✓ Test de traction: positif si + de 2 cheveux sur 10
- ✓ **Topographie:** diffuse ou localisée



Examen physique

- ✓ Aspect des cheveux: surtout pour les alopecies congénitales (=dysplasie pileaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)
- ✓ Densité: pour authentifier l'alopecie
- ✓ Test de traction: positif si + de 2 cheveux sur 10
- ✓ Topographie: diffuse ou localisée
- ✓ **Etat du cuir chevelu**: sain ou inflammatoire



Examen physique

- ✓ Aspect des cheveux: surtout pour les alopecies congénitales (=dysplasie pilaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)
- ✓ Densité: pour authentifier l'alopecie
- ✓ Test de traction: positif si + de 2 cheveux sur 10
- ✓ Topographie: diffuse ou localisée
- ✓ Etat du cuir chevelu: sain ou inflammatoire
- ✓ Chez la femme: signes associés d'hirsutisme



Examen physique

- ✓ Aspect des cheveux: surtout pour les alopécies congénitales (=dysplasie pilaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)
- ✓ Densité: pour authentifier l'alopecie
- ✓ Test de traction: positif si + de 2 cheveux sur 10
- ✓ Topographie: diffuse ou localisée
- ✓ Etat du cuir chevelu: sain ou inflammatoire
- ✓ Chez la femme: signes associés d'hirsutisme
- ✓ Chez l'enfant: rechercher d'autres atteintes (ongles, dents)
- ✓ **Lumière de Wood**: + si teigne tondante



Examen physique

- ✓ Aspect des cheveux: surtout pour les alopécies congénitales (=dysplasie pilaire) ou suspicion de trichotillomanie (= cheveux cassés)
- ✓ Densité: pour authentifier l'alopécie
- ✓ Test de traction: positif si + de 2 cheveux sur 10
- ✓ Topographie: diffuse ou localisée
- ✓ Etat du cuir chevelu: sain ou inflammatoire
- ✓ Chez la femme: signes associés d'hirsutisme
- ✓ Chez l'enfant: rechercher d'autres atteintes (ongles, dents)
- ✓ Lumière de Wood: + si teigne tondante

Conduite à tenir

Consultation pour une » chute de cheveux »

Dans 90% des cas il s'agit d'un **effluvium télogène (contexte +++)**

Phénomène transitoire liée au passe en phase télogène d'un nombre de cheveux important

➤ Rassurer le patient et surveiller

Si persistance

Bilan:

NFS

Ferritinémie

Vit B9 et B12

TSH

VS, CRP

TPHA/VDRL

VIH



Les grandes causes

AAG

1^{ère} cause d'alopécie chez l'homme et la femme

Pas d'examen complémentaire SAUF chez la femme **si hirsutisme** associé

Faire:

Testostérone

DHEA

17OH progestérone

Delta-4-androstènedione



Les grandes causes

Pelade

Alopécie en plaques ou totale sur cuir chevelu sain
Origine auto-immune



Les grandes causes

Teignes

➤ Teignes tondantes

Microsporique ou Trichophytique

Plaques alopeciques squameuses grisâtres

Germes anthropophiles

Epidémie

➤ Teignes suppurées

Plaque très inflammatoire, érythémateuse, pustules

Germe zoophile, contexte rural

Contamination par animaux domestiques ou inter-humaine





Les grandes causes

Alopécies cicatricielles (pseudo pelade)

- Lupus discoïde +++
- Lichen

Indication à une biopsie !!!



Points importants

1. Le follicule pileux est une structure dynamique régie par un cycle pileux sous l'influence de multiples facteurs
2. L'interrogatoire et l'examen clinique sont essentiels pour l'orientation diagnostique d'une alopecie permettant de les classer en alopecie acquise/constitutionnelle, diffuse/localisée et cicatricielle/non cicatricielle.
3. Les examens complémentaires ont des indications limitées
4. L'effluvium télogène, l'alopecie androgénogénétique et la pelade sont les trois principales causes d'alopecie
5. Seules les alopecies cicatricielles à type de pseudo-pelade justifient la réalisation d'une biopsie du cuir chevelu
6. Il faut savoir évoquer une teigne devant tout état squameux, alopecique chez l'enfant
7. La prise en charge psychologique est essentielle le retentissement psychologique étant souvent majeur en particulier chez la femme.